EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL	: HOSPITAL DE SAN CARLOS	N° EGRESO	: 84943
SERVICIO	: UNIDAD EMERGENCIAS		
FECHA	: 2024-05-21 10:47:37		

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: AGUSTIN ESNALDO AREVALO VELOSO			**RUN**	: 5.029.912-0
F.Nac	: 28-08-1946	**Edad**	: 77 AÑOS, 8 MESES	**Género**	: Masculino
Dirección	: El Peumo 979			**Comuna**	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	**Teléfono**	: 986999608		
Fecha Ingreso	: 20-05-2024	**Fecha Egreso**	: 2024-05-21 10:47:37	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	**Derivación**	: ATENCION PRIMARIA

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J44.9-ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

EPOC reagudizado
Hipertensión arterial
Nódulo pulmonar LII a estudio

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J44.9-ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente de 77 años con antecedentes de EPOC grupo C, hipotiroidismo e HTA, consulta por cuadro de 15 días de disnea, tos y compromiso del estado general. Al ingreso taquipneico, saturando 94% ambiental, con sibilancias bilaterales. Se hospitaliza para manejo de EPOC descompensado.
Se realiza AngioTAC de tórax que descarta TEP, pero evidencia nódulo pulmonar de 7 mm en LII, sin adenopatías mediastínicas.
Evoluciona favorablemente, con saturación esperable para su condición basal. Se decide egreso para continuar manejo ambulatorio con hospitalización domiciliaria.

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo
2. Régimen liviano hipograsado
3. Control con médico tratante para evaluar nódulo pulmonar y definir estudio.
4. Control con kinesiólogo para kinesioterapia respiratoria.
5. Amoxicilina/Ac. Clavulánico 875/125 mg cada 12 horas vía oral por 7 días.
6. Salbutamol 2 puff cada 6 horas
7. Bromuro de Ipratropio 2 puff cada 6 horas
8. Continuar con tratamientos habituales de base.

Félix Sanhueza Luna
MEDICO TRATANTE
14542245-0

JEFE SERVICIO